

ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΡΙΔΥΜΟΥ

Γενικά: Η Νευραλγία Τριδύμου (NT) προσβάλλει γυναίκες και άνδρες, ηλικίας συνήθως άνω των 50 ετών, με αναλογία περίπου 3:2 αντίστοιχα και επί το πλείστον είναι ιδιοπαθής.

Εμφανίζεται συχνότερα στη δεξιά πλευρά του προσώπου, ενώ στο 60% των περιπτώσεων αφορά στον 2^ο ή/και στον 3^ο κλάδο (άνω και κάτω γναθικό νεύρο). Αν η NT εκδηλώνεται σε άτομο μικρότερο των 30 ετών, μπορεί να υποκρύπτει Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ).

Η παθοφυσιολογία της τριδυμαλγίας δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Πιθανώς προκαλείται από συμπίεση του Τριδύμου (V) νεύρου, από αγγεία ή κάποιον όγκο, στην έκφυσή του από το εγκεφαλικό στέλεχος. Η τοπική συμπίεση προκαλεί απομυελίνωση παρόμοια με της ΠΣ, με αποτέλεσμα την υπερδιέγερση των νευρικών ινών και την παραγωγή έκτοπων ώσεων.

Κλινική εικόνα: Οι ασθενείς συνήθως προσέρχονται με οξύ, έντονο, διαξιφιστικό άλγος «σαν μαχαίρι» διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, που συχνά εκλύεται με τη μάσηση τροφής ή κατά το ξύρισμα και εντοπίζεται κυρίως στις παρειές, τις γνάθους, τα ούλα, τα χείλη, εμφανίζουν δακρύρροια, σιελόρροια, έξαψη, συσπάσεις του προσώπου (*tic douloureux*), κ.ά. Ο πόνος μπορεί να υποτροπιάσει αρκετές φορές, κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύκτας. Τονίζεται, επίσης, ότι η αισθητικότητα της πάσχουσας περιοχής ουδέποτε χάνεται!

Απεικόνιση: Μόλις τεθεί η διάγνωση της NT, ο ασθενής δέον είναι να υποβληθεί σε MRI εγκεφάλου, για τη διερεύνηση ειδικών παθολογικών καταστάσεων, όπως όγκοι γεφυρο-παρεγκεφαλιδικής γωνίας (*μηνιγγίωμα, επιδερμοειδές, παραγαγγλίωμα, αραχνοειδής κύστη, χολοστεάτωμα, μεταστάσεις*) ή ΠΣ, που πιθανώς να προκαλούν δευτεροπαθή τριδυμαλγία. Η μαγνητική αγγειογραφία (MRA) είναι επίσης χρήσιμη σε περίπτωση υποψίας πίεσης του τριδύμου νεύρου από αιμοφόρο αγγείο (*άνω παρεγκεφαλιδική αρτηρία*) ή από ανεύρυσμα.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Χορηγούμε ενδοφλεβίως, με μεγάλη προσοχή, 1-2 amp. **Κλοναζεπάμη** (*Rivotril*) 1 mg, σε ορό 250-500 ml NaCl 0,9%, εντός διαστήματος 30-45 λεπτών. [Σημ: Η κατασταλτική δράση των Βενζοδιαζεπινών αναστρέφεται με τη χορήγηση Φλουμαζενίλης (*Anexate*)].

Αγωγή κατ' οίκον:

2. Για την κατ' οίκον αγωγή και για τις υποτροπές, χορηγείται tab. 200 mg **Καρβαμαζεπίνη** (*Tegretol*), σε δόση 1x1 έως και 2x3 (po), ελέγχοντας τακτικά την ηπατική λειτουργία. Η **Οξκαρβαζεπίνη** (*Trileptal* 300 mg, 1x2 έως και 2x3 ημερησίως) έχει ελαφρώς πιο μικρή αποτελεσματικότητα από την Καρβαμαζεπίνη, αλλά και λιγότερες παρενέργειες.
3. Εναλλακτικά, χορηγείται **Γκαμπαπεντίνη** (*Neurontin*): caps. 300 mg, σε δόση 1x3 έως 1x5, αλλά ενίοτε και σε δόση 2x4, ειδικά στους πάσχοντες από Πολλαπλή Σκλήρυνση, μέχρι της ύφεσης ή της πλήρους παρέλευσης των συμπτωμάτων της τριδυμαλγίας.
4. Εναλλακτικά, δίνουμε **Βακλοφαίνη**: tab. *Miorel* 10 mg, σε δοσολογία 1x4 έως και 2x4, για 10-20 ημέρες, με σταδιακή μείωση της δόσης και αναλόγως της ύφεσης του άλγους.
5. Συζήτηση με τον ασθενή για άλλες μεθόδους ή την πιθανότητα χειρουργικής επέμβασης. Η χειρουργική επέμβαση απευθύνεται σε εκείνους τους ασθενείς που δεν ανέχονται τις υποτροπές ή/και τις παρενέργειες των χορηγούμενων, για τη νευραλγία, φαρμάκων.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες μέθοδοι που εφαρμόζονται σήμερα, είναι:

- Η διαδερμική νευρόλυση του γασσέριου (*μηνοειδούς*) γαγγλίου.
- Η διαδερμική έγχυση γλυκερόλης ή περιοχική ένεση Botox.
- Η διαδερμική αποσυμπίεση του γαγγλίου με ειδικό μπαλόνι.
- Η μικροαγγειακή αποσυμπίεση του πάσχοντος νεύρου.
- Η θεραπεία με ραδιοχειρουργική μέθοδο - Gamma Knife.

Υπενθύμιση: Τα κοινά αναλγητικά, τα οπιοειδή αναλγητικά, τα ΜΣΑΦ, καθώς και οι συνδυασμοί τους, δεν είναι αποτελεσματικά κι επομένως ουδεμία θέση έχουν στη θεραπευτική αντιμετώπιση της Νευραλγίας του Τριδύμου.

